

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Cytarabine 50mg

(테포사이트주50mg/5ml, 먼디파마)

- ☐ **제형, 성분함량 :**
 - 1 바이알 중 Cytarabine 50mg
- ☐ **효능 효과 :**
 - 성인 및 노인의 림프종성 뇌수막염의 경막내 치료
- ☐ **약제 급여 평가 위원회 심의일**
2009년 제7차 약제급여평가위원회 : 2009년 7월 24일
 - 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2009년 4월 16일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 비급여

- 신청품은 “성인 및 노인의 림프종성 뇌수막염”에 사용하는 약제로 Free Cytarabine에 비해 CSF(Cerebro spinal fluid)에서의 세포학적 반응률을 개선시키고 투여 편의성이 인정되나 경제성평가 결과 비용-효과적이지 않으므로 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “성인 및 노인의 림프종성 뇌수막염의 치료”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하며, 동일 적응증에 허가받은 약제는 등재되어 있지 않으나 현재 동일 적응증에 Cytarabine, Methotrexate 등의 약제가 보험에서 사용 가능하므로¹⁾, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 Lymphomatous 또는 Carcinomatous Meningitis 환자의 치료에 사용²⁾하는 약제이며, 2주에 한번 경막내 투여로 CSF에서 Cytarabine의 유효 농도를 유지시킴³⁾.
- CSF 세포 양성의 림프종 환자 28명을 대상으로 유리 Cytarabine과 비교한 open-label, randomized, parallel-group 다기관 임상시험⁴⁾에서 신청품군의 반응율이 유의하게 높았으며(71% for DepoCyt and 15% for ara-C ($P = .006$)), Time to neurologic progression과 survival은 신청품군에서 높은 경향을 보이나 통계적 차이는 없음(median, 78.5 v 42 days and 99.5 v 63 days; $P > .05$).
 - 이상반응은 대부분 일과성이었으며 치료 주기의 종료로 해결되었음. 10% 이상 발생한 이상 반응은 두통으로 DepoCyt 군에서 더 많이 발생하였으나(27% v 2% of cycles) 대부분 낮은 등급으로 조절 가능하였음.
- CSF 세포 양성의 림프종 환자 25명을 대상으로 유리 Cytarabine과 비교한 open label, Randomized, phase II, parallel-group, 다기관 임상시험⁵⁾에서 신청품군의 반응율이 유의하게 높았으며(72% for DepoCyt and 18% for ara-C ($P = .002$)) Time to neurologic progression은 신청품군에서 높은 경향을 보이나 통계적 차이는 없음(median, 77 v 48 days).
 - 대부분의 이상반응은 경미하고 일과성이었으며 리포솜화 시타라빈의 축적독성에 관한 증거는 없었음.

○ 비용 효과성

- 관련 급여기준 및 제외국 임상지침 등을 고려하여 “Cytarabine, Methotrexate”을 대체가능 약제 및 투약비용 비교대상 약제로 선정함.
 - 투약비용 비교시, 신청품인 Liposomal Cyrtarabine의 1회 소요비용(■■■■원)은 비교가능약제인 Cytarabine(■■■■~■■■■원), Methotrexate(■■■■원) 대비 고가로 검토됨.
- 신청품은 2주 한번 경막내 투여로 Free cytarabine 경막내 투여에 비해 편의성 개선이 인정되며 세포학적 반응률이 유의하게 높으나 비용이 고가로 경제성 평가 제출대상에 해당함.
 - 제출된 경제성평가자료(비용-효과 분석) 검토결과, ICER/LYG가 약 ■■■■원으로 신청품은 비교대안에 비해 비용 효과적이지 않음.

○ 재정 영향

- 제약사의 신청품 투여 예상환자에 따른 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁶⁾은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 되고, Methotrexate, Cytarabine의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원 증가할 것으로 예상됨⁷⁾.
 - 해당 질환에 대한 상병코드가 없어 정확한 환자수 추정이 어려우며, 제약사에서 제시한 신청품 예상 사용 환자수⁸⁾가 초과될 경우 재정소요금액은 더 증가할 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7국가 중 미국, 독일, 이태리 스위스, 영국에 등재되어 있음.

Reference

- 1) 암환자에게 처방 · 투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항
- 2) Cancer Principles and Practice of Oncology, 7th Ed, Harrison's Online, Williams Hematology 7th(2006), NCCN Practice Guidelines in Oncology - v1. 2008
- 3) Harrison's Online, Williams Hematology 7th(2006)
- 4) Glantz MJ et. al Randomized trial of a slow-release versus a standard formulation of cytarabine for the intrathecal treatment of lymphomatous meningitis.J Clin Oncol. 1999 Oct;17(10):3110-6.
- 5) Howell. Liposomal Cytarabine for the Treatment of Lymphomatous Meningitis. Biological therapy of Lymphoma. April 2003 Vol. 6, No. 1.
- 6) 1인당 연간 예상사용량 * 연간 환자수(단, 1인당 예상 투여횟수는 비교 약제의 경우 관련 임상문헌 및 학회의견 제약사의 투여횟수 등을 고려해 모두 ■회 투여로, 신청품은 임상문헌 및 제약사의 투여횟수 등을 고려하여 ■회로 추정함.)
- 7) 도입 후 소요금액-도입 전 소요금액(단, 도입전 소요금액은 2008년 가중평균가를 각 성분별 청구환자수에 적용하여 소요금액을 산정하고 도입 후 소요금액은 신청품의 제약사 예상점유율에 따른 소요금액임.)
- 8) 제약사에서는 첫 해 약 ■명을 해당 질환 환자로 추정하였으며 관련 학회에서는 약 ■명~명 정도로 추정하였으므로 이를 고려하여 제약사 예상 환자수를 이용함.